

Questionário de Feedback – Validação do Protocolo Orofacial

Objetivo

Coletar avaliação de cuidadores e profissionais sobre usabilidade, aceitabilidade, carga de trabalho, tempos e utilidade clínica do protocolo em cenários domiciliar e ambulatorial, para orientar ajustes antes do estudo completo.

Escala

Likert 1–5 (1=Fortemente em desacordo; 2=Desacordo; 3=Neutro; 4=Concordo; 5=Fortemente de acordo; NA=Não aplicável)

Meta: média ≥ 4 e $\geq 80\%$ de respostas 4–5 nas áreas-chave.

Módulo Cuidadores (aplicar após T0 e T24–48 h)

1. As instruções foram claras e fáceis de entender.
2. A duração da sessão (15–30 min) foi adequada para mim e para o paciente.
3. O paciente esteve confortável durante triagem, anamnese e exame.
4. As perguntas sobre alimentação, higiene, sono e comportamentos foram pertinentes.
5. Registrar escores e observações foi simples e rápido.
6. Repetir a avaliação em T24–48 h foi factível e útil.
7. Senti-me capaz de identificar sinais de alerta e buscar ajuda.

8. A privacidade foi respeitada ao longo do processo.
9. A carga de trabalho para mim como cuidador foi sustentável.
10. A versão “light” seria útil em contextos com poucos recursos.
11. As tecnologias opcionais (apps/IA) foram compreensíveis e não invasivas.
12. Prefiro o follow-up por visita, telefone ou mensagem (especificar).
13. No geral, este protocolo reduziu incertezas e atrasos nas decisões.
14. Eu participaria novamente, se necessário.
15. Satisfação geral com a equipe e o protocolo.

Perguntas abertas

- O que funcionou melhor para você e para o paciente?
- O que poderia ser aprimorado (linguagem, tempos, ferramentas)?
- Encontrou dificuldades práticas (horários, ambiente, equipamentos)?

Módulo Profissionais (aplicar após T0 e T24-48 h)

1. Materiais (fichas, check-lists) foram claros e completos.
2. O tempo de aplicação (15-30 min) foi alcançado.
3. O follow-up em T24-48 h foi logisticamente viável e clinicamente útil.
4. Manter escala e condições padronizadas entre T0 e T24-48 h foi simples.

5. O treinamento garantiu confiabilidade entre avaliadores.
6. A qualidade dos dados (completude, legibilidade) foi satisfatória.
7. A versão “light” manteve especificidade sem comprometer o protocolo.
8. Tecnologias opcionais agregaram valor sem aumentar complexidade.
9. O protocolo se integra aos fluxos do SUS e atende à LGPD.
10. Avaliação geral de utilidade clínica e adoção.

Perguntas abertas

- Principais barreiras operacionais e sugestões de solução.
- Melhorias em ferramentas, treinamento e decisões clínicas.
- Exemplos de impacto no manejo ou priorização clínica.

Aplicação e Análise

- Somente digital ou papel seguro; aplicar em T0 e T24–48 h; breve check em T7.
- Analisar médias por item, % de respostas 4–5 ($\geq 80\%$) e temas abertos.
- Itens críticos devem motivar booster de treinamento e reavaliação em coortes subsequentes.

Versão Light (6 itens + 1 aberto)

- Duração aceitável
- Clareza das instruções
- Viabilidade do follow-up T24-48 h
- Conforto do paciente
- Utilidade percebida
- Satisfação geral
- Sugestões de melhoria

Nota ética

Feedback anonimizados e armazenados conforme LGPD e aprovações éticas.